

보건복지부 고시 제2026-117호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2026-92호(2026. 4. 22.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 5월 27일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

II. 약제 "[430] Vosoritide 주사제(품명: 복스조고주 0.4 밀리그램 등)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[일반원칙] 당뇨병용제, [142] Apremilast 경구제(품명: 오테리아정 등), [142] Filgotinib 경구제(품명: 지셀레카정 100밀리그램 등), [142] Guselkumab 주사제(품명: 트렘피어프리필드시린지주 등), [142] Ozanimod 경구제(품명: 제포시아캡슐 0.92밀리그램 등), [142] Risankizumab 주사제(품명: 스카이리치프리필드시린지주 등), [142] Tofacitinib 경구제(품명: 켈잔즈정 5밀리그램, 켈잔즈시럽 등), [142] Upadacitinib 경구제(품명: 린버크서방정 15밀리그램, 30밀리그램), [142] Ustekinumab 주사제(품명: 스텔라라 프리필드주 45mg 등), [439] Vedolizumab 주사제(품명: 킨텔레스주 등), [629] Glecaprevir+Pibrentasvir 경구제(품명: 마비렛정), [621] Aztreonam 주사제(품명: 메작담주사 등), [629] Sofosbuvir + Velpatasvir 경구제(품명: 엡클루사정)"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 6월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[430] 조직세포의 치료 및 진단 목적			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[430] Vosoritide주사제 (품명: 복스조고주 0.4 밀리그램 등)	<신 설>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. -아 래 - 가. 투여대상 유전자검사(FGFR3변이: Gly380Arg 또는 Gly375Cys)를 통해 확인된 골단(성장판)이 닫히지 않은 4개월 이상의 소아 연골무형성증 환자로, 사지연골연장술을 받지 않은 경우 나. 평가방법 치료 시작 후 6개월마다 평가하여 다음 중 하나라도 해당되는 경우 투여 중단함. 1) 골단(성장판)이 닫힌 경우 2) 연간성장속도(Annual Growth Velocity)가 1.5cm/년 미만인 경우 다. 투여 및 약제관리 1) 1회 처방기간은 퇴원 또는 외래의 경우 최대 30일분까지로 함. 2) 동 약제는 자가 주사제제인 점을 고려하여, 동 약제의 투여기간 등의 확	○ Vosoritide 주사제 (품명: 복스조고주 0.4, 0.56, 1.2mg)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

		인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. 라. 동 약제는 성장 장애 또는 골격 이형성 관리에 자격을 갖춘 의사가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여, 투여중단 시 반응평가에 대한 객관적 자료(성장 기록표, 검사결과지, 임상진료기록지 등)를 반드시 제출하여야 함.	
※ 관련근거 · FDA label (2024) · EMA summary of production characteristics (2024) · TGA (2022) · Williams Textbook of Endocrinology (2025) · Nelson Textbook of Pediatrics (2025) · Firestein & Kelley’s Textbook of Rheumatology (2025) · International consensus guidelines on the implementation and monitoring of vosoritide therapy in individuals with achondroplasia (2025) · Once-daily, subcutaneous vosoritide therapy in children with achondroplasia: a randomised, double-blind, phase 3, placebo-controlled, multicentre trial Lancet 2020; 396: 684–92 · Safe and persistent growth-promoting effects of vosoritide in children with achondroplasia: 2-year results from an open-label, phase 3 extension study Genetics in Medicine (2021) 23:2443–2447 · Vosoritide therapy in children with achondroplasia aged 3–59 months: a multinational, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial Lancet Child Adolesc Health 2023 · 대한소아내분비학회(소내학 2025-34호, 2025.03.28.) · 대한의학유전학회(2025-24, 2025.04.01.) · 대한소아정형외과학회 (대소정 25-03호, 2025.04.02.) · 대한소아청소년과학회(대소학 2025-327호, 2025.03.31.), 대한소아청소년과학회-유전대사분과 의견 · Public Summary Document – July 2022 PBAC Meeting with September 2022 and November 2022 Addendums · HAS (21.12.15.) · NCPE (23.10.5.)			

[별지 2]

[일반원칙] 당뇨병용제															
구 분	세부인정기준 및 방법		사유												
	현 행	개 정(안)													
[일반원칙] 당뇨병용제	인슐린 비의존성 당뇨병(제2형 당뇨병) 환자에게 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 허가사항 범위이지만 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담함. - 아 래 - (생 략) ※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (생 략) [경구제 중 2제 복합제] <table><tr><th>성분군</th><th>성분명</th></tr><tr><td colspan="2">(생 략)</td></tr><tr><td>SGLT-2 inhibitor계 +Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)</td><td>Dapagliflozin+Pioglitazone HCl <u><추 가></u></td></tr></table>	성분군	성분명	(생 략)		SGLT-2 inhibitor계 +Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Pioglitazone HCl <u><추 가></u>	(현행과 같음) - 아 래 - (현행과 같음) ※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (현행과 같음) [경구제 중 2제 복합제] <table><tr><th>성분군</th><th>성분명</th></tr><tr><td colspan="2">(현행과 같음)</td></tr><tr><td>SGLT-2 inhibitor계 +Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)</td><td>Dapagliflozin+Pioglitazone HCl, <u>Empagliflozin+Lobeglitazone sulfate</u></td></tr></table>	성분군	성분명	(현행과 같음)		SGLT-2 inhibitor계 +Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Pioglitazone HCl, <u>Empagliflozin+Lobeglitazone sulfate</u>	○ 또한, ‘듀비엠과정 0.5/25밀리그램’ 등 복합제 4품목이 등재 예정임에 따라, 대상 약제의 ‘경구제 중 2제 복합제’ 중 ‘SGLT-2 inhibitor계 + Thiazolidinedione계’ 성분군에 해당 성분명을 추가하기로 하며 ‘경구제 중 3제 복합제’에 SGLT-2 inhibitor계 + Thiazolidinedione계 + Biguanide계 성분군을 추가하고 해당 성분명을 추가함.
성분군	성분명														
(생 략)															
SGLT-2 inhibitor계 +Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Pioglitazone HCl <u><추 가></u>														
성분군	성분명														
(현행과 같음)															
SGLT-2 inhibitor계 +Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Pioglitazone HCl, <u>Empagliflozin+Lobeglitazone sulfate</u>														

[일반원칙] 당뇨병용제				
구 분	세부인정기준 및 방법			사유
	현 행		개 정(안)	
	성분군	성분명	성분군	성분명
	(생 략)		(현행과 같음)	
	[경구제 중 3제 복합제]		[경구제 중 3제 복합제]	
	성분군	성분명	성분군	성분명
	(생 략)		(현행과 같음)	
	SGLT-2 inhibitor계 +DPP-IV inhibitor계 +Biguanide계	Dapagliflozin+Sitagliptin phosphate+Metformin HCl Dapagliflozin +Sitagliptin HCl +Metformin HCl Evogliptin+Dapagliflozin +Metformin HCl Empagliflozin+Sitagliptin phosphate+Metformin HCl Empagliflozin+Linagliptin +Metformin HCl	SGLT-2 inhibitor계 +DPP-IV inhibitor계 +Biguanide계	(현행과 같음)
	<추 가>		SGLT-2 inhibitor계 +Thiazolidinedione계 +Biguanide계	Empagliflozin +Lobeglitazone sulfate +Metformin HCl

- 5 -

[일반원칙] 당뇨병용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	[주사제] (생 략)	[주사제] (현행과 같음)	
※ 관련근거 <요양급여 신규등제에 따른 급여기준 신설>			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)				
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)			사유
	현 행		개 정(안)	
[142] Guselkumab 주사제 (품명: 트렘피어프리퀼드스린지 주 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 다. (생 략) <신 설>		1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 궤양성 대장염 1) 투여대상 <u>Corticosteroid나 6-Mercaptopurine 또는 Azathioprine 등 보편적인 치료 약제에 대해 적절한 반응을 나타내지</u>	○ 교과서, 가이드라인, 임상 연구문헌, 전문가 의견 등을 참조하여 궤양성 대장염 및 크론병에 guselkumab 주사제의 급여를 확대함.

- 6 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>않거나 내약성이 없는 경우 또는 상기 약제가 금기인 중등도-중증의 궤양성 대장염 환자</u> <u>※ 중등도-중증의 궤양성 대장염 환자</u> : <u>아래의 점수를 합산하여 중등도-중증 궤양성 대장염 여부를 판정(Mayo score 6 to 12 and Endoscopy subscore $\geq$ 2)</u> ※ 궤양성대장염 활동평가를 위한 메이요 점수시스템(Mayo Scoring System for Assessment of Ulcerative Colitis Activity) 배변빈도(Stool frequency) 0 = Normal no. of stools for this patient 1 = 1 to 2 stools more than normal 2 = 3 to 4 stools more than normal 3 = 5 or more stools more than normal Subscore, 0 to 3 직장출혈(Rectal bleeding) 0 = No blood seen 1 = Streaks of blood with stool less than half the time 2 = Obvious blood with stool most of the time 3 = Blood alone passes Subscore, 0 to 3 내시경 결과(Findings on endoscopy)	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
		0 = Normal or inactive disease 1 = Mild disease (erythema, decreased vascular pattern, mild friability) 2 = Moderate disease (marked erythema, lack of vascular pattern, friability, erosions) 3 = Severe disease (spontaneous bleeding, ulceration) Subscore, 0 to 3 의사의 종합평가(Physician's global assessment) 0 = Normal 1 = Mild disease 2 = Moderate disease 3 = Severe disease Subscore, 0 to 3 2) 평가방법 <u>첫 투약 후 12-16주에 평가하여 다음 각 호의 조건을 모두 충족하는 경우 지속적인 투여를 인정함.</u> - 다 음 - <u>가) Mayo score가 최초 투여시점보다 30% 이상 감소하고 3점 이상 감소한 경우</u> <u>나) Rectal bleeding subscore 1점</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>이상 감소 또는 Rectal bleeding subscore 0점 또는 1점인 경우</u> 3) <u>투여방법: 유지용량은 매 8주마다 100mg 투여를 인정함.</u> 4) <u>교체투여</u> 가) <u>다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 등 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부)</u> - 다 음 - (1) <u>종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제</u> (2) <u>인터루킨(Interleukin, IL)-12/23 억제제: Ustekinumab 주사제</u> (3) <u>α4β7 인테그린(Integrin) 억제제: Vedolizumab 주사제</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	<신 설>	(4) <u>야누스 인산화효소(Janus kinase, JAK) 억제제: Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib 경구제</u> (5) <u>스핑고신 1-인산염(Sphingosine 1-phosphate) 수용체 조절제: Ozanimod 경구제</u> 나) <u>교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함</u> 마. <u>크론병</u> 1) <u>투여대상</u> <u>보편적인 치료(2가지 이상의 약제: 코르티코스테로이드제나 면역억제제 등)에 반응이 없거나 내약성이 없는 경우 또는 이러한 치료법이 금기인 중등도-중증의 활성 크론병 (크론병활성도(CDAI) 220 이상)</u> ※ 크론병 활성도(CDAI) : 아래의 점수를 합산하여 활성도(CDAI: Crohn's Disease Activity Index)를 인위적으로	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
		정하여 활동성 여부를 판정 (1) 1주에 설사횟수의 합 × 2 (2) 1주에 복통의 정도의 합(증상없음=0, 경증=1, 중등증=2, 중증=3) × 5 (3) 1주에 일반적으로 전신 안녕감의 합(좋음=0, 평균이하=1, 나쁨=2, 매우 나쁨=3, 극도로 나쁨=4) × 7 (4) 다음 6항목 중 환자가 현재 나타내는 해당 항목의 개수 × 20 (가) 관절염/관절통 (나) 홍채염/포도막염 (다) 결절성홍반, 괴저성농피증, 아프타성구내염 (라) 항문열상, 누공 혹은 농양 (마) 기타 누공 (바) 지난주간 37.8℃이상 발열 (5) 설사 때문에 마약성 지사제 복용시 × 30 (6) 복부종괴(없음=0, 의심=2, 확정적=5) × 10 (7) 헤마토크리트(남:47, 여:42-환자 Hct치) × 6 (8) ((표준체중 - 환자체중)/표준체중) × 100(%) ※ 소아 크론병 활성도(PCDAI: Pediatric Crohn's Disease Activity Index) : Hyams JS, et al. Development and validation of a pediatric Crohn's disease activity index. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1991 May;12(4):439-47. 참조	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
		2) 평가방법 <u>첫 투약 후 12-16주에 CDAI가 70점 이상 감소 또는 총 CDAI score의 25% 이상 감소된 경우에 한하여 유지요법을 인정함.</u> 3) 투여방법: <u>유지용량은 매 8주마다 100mg 투여를 인정함.</u> 4) 교체투여 가) <u>다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부)</u> - 다 음 - (1) <u>종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제:</u> <u>Adalimumab, Infliximab</u> <u>주사제</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	2. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF- α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.	(2) 인터루킨(Interleukin, IL)-12/23 억제제: Ustekinumab 주사제 (3) $\alpha 4\beta 7$ 인테그린(Integrin) 억제제: Vedolizumab 주사제 (4) 야누스 인산화효소(Janus kinase, JAK) 억제제: Upadacitinib 경구제 나) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함.	
※ 관련근거 · 식품의약품안전처 허가사항 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 337: Inflammatory Bowel Disease · Goldman-Cecil Medicine, 27e, 2024> Chapter 127. INFLAMMATORY BOWEL DISEASE · Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 12e, 2026> Chapter 118 Management of Inflammatory Bowel Diseases · Current Medical Diagnosis & Treatment 2026> Chapter 17-35: Inflammatory Bowel Disease · Na SY, et al. IBD Research Group of the Korean Association for the Study of Intestinal Diseases. Korean clinical practice guidelines on biologics and small molecules for moderate-to-severe ulcerative colitis. Intest Res. 2023 Jan;21(1):61-87. · Rubin DT, et al. ACG Clinical Guideline Update: Ulcerative Colitis in Adults. Am J Gastroenterol. 2025 Jun 3;120(6):1187-1224.			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
· Moran GW, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on inflammatory bowel disease in adults: 2025. Gut. 2025 Jun 23;74(Suppl 2):s1-s101. · Singh S, et al. AGA Living Clinical Practice Guideline on Pharmacological Management of Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2024 Dec;167(7):1307-1343. · Raine T, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment. J Crohns Colitis. 2022 Jan 28;16(1):2-17. · Rubin DT, et al. Guselkumab in patients with moderately to severely active ulcerative colitis (QUASAR): phase 3 double-blind, randomised, placebo-controlled induction and maintenance studies. Lancet. 2025 Jan 4;405(10472)33-49. · Chen B, et al. Guselkumab in East Asians With Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis: Subgroup Analysis of the QUASAR Induction and Maintenance Studies. J Gastroenterol Hepatol. 2025 Sep;40(9):2197-2208. · Shehab M, et al. Comparative Efficacy of Biologics and Small Molecule in Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2025 Feb;23(2):250-262. · Barberio B, et al. Network Meta-Analysis: Efficacy of Biological Therapies and Small Molecules as Maintenance Therapy in Ulcerative Colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2025 Jul;62(1):4-21. · Long M, et al. Efficacy and safety of subcutaneous guselkumab induction therapy in participants with moderately to severely active ulcerative colitis (ASTRO): a double-blind, treat-through, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2026 Jan 13:S2468-1253(25)00322-X. · Gary R. Lichtenstein , et al. ACG Clinical Guideline: Management of Crohn’s Disease in Adults. Am J Gastroenterol 2025;120:1225-1264. · Frank I. Scott , et al. AGA Living Clinical Practice Guideline on the Pharmacologic Management of Moderate-to-Severe Crohn’s Disease. Gastroenterology 2025;169:1397-1448 · Seong-Joon Koh, et al. Korean clinical practice guidelines on biologics for moderate to severe Crohn’s disease. Intest Res 2023;21(1):43-60 · Hannah Gordon, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn’s Disease: Medical Treatment. Journal of Crohn’s and Colitis, 2024, 18, 1531-1555 · Remo Panaccione, et al. Efficacy and safety of intravenous induction and subcutaneous maintenance therapy with guselkumab for patients with Crohn’s disease (GALAXI-2 and GALAXI-3): 48-week results from two phase 3, randomised, placebo and active comparator-controlled, double-blind, triple-dummy trials, Lancet 2025; 406: 358-75			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
· Tim Disher, et al. One Year Efficacy of Guselkumab Versus Advanced Therapies for the Treatment of Moderately to Severely Active Crohn's Disease: A Network Meta analysis, Adv Ther (2025) 42:2708–2727 · Claudia Dziegielewska, et al. IL-23p19 Antagonists vs Ustekinumab for Treatment of Crohn's Disease: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Am J Gastroenterol 2025;00:1–8.			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Filgotinib 경구제 (품명: 지셀레카정 100밀리그램 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인 정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (생 략) 나. 성인의 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염 1), 2) (생 략) 3) 종 양 괴 사 인 자 알 파 저 해 제 (TNF- α inhibitor: Adalimumab, Golimumab,	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인 정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. 성인의 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염 1), 2) (현행과 같음) 3) <u>교체투여</u> <u>가) 다음 약제 투여에도 효과가 없거나</u>	○ 궤양성 대장염에 Guselkumab 주사제(품 명: 트렘피어프리필드시 린지 등)가 급여 확대됨 에 따라 교체투여 급여 기준에 해당 성분명을 추가함. ○ 급여기준 전반에 걸쳐 가독성 향상을 위한 문구

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	2. ~ 4. (생 략)	2. ~ 4. (현행과 같음)	
[142] Ozanimod 경구제 (품명: 제포시아캡슐 0.92밀리그램 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (생 략) 2. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Tofacitinib, Filgotinib, Upadacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (현행과 같음) 2. <u>교체투여</u> 가. 다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - 1) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: <u>Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제</u> 2) 인터루킨(Interleukin, IL)-12/23 억제제: <u>Ustekinumab 주사제</u> 3) 인터루킨(Interleukin, IL)-23 억제제: <u></u>	

- 17 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	3. ~ 4. (생 략)	3. ~ 4. (현행과 같음)	
[142] Tofacitinib 경구제 (품명: 젤잔즈정 5밀리그램, 젤잔즈시럽 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (생 략) 다. 성인의 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염 1), 2) (생 략) 3) 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제)	<u>Guselkumab 주사제</u> 4) $\alpha 4\beta 7$ 인테그린(Integrin) 억제제: <u>Vedolizumab 주사제</u> 5) 야누스 인산화효소(Janus kinase, JAK) 억제제: <u>Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib 경구제</u> 나. 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함 3. ~ 4. (현행과 같음) 1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (현행과 같음) 다. 성인의 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염 1), 2) (현행과 같음) 3) <u>교체투여</u> 가) 다음 약제 투여에도 효과가 없거나	

- 18 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	또는 Ustekinumab, Vedolizumab 주사제, Ozanimod 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.	부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - (1) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제 (2) 인터루킨(Interleukin, IL)-12/23 억제제: Ustekinumab 주사제 (3) 인터루킨(Interleukin, IL)-23 억제제: Guselkumab 주사제 (4) α4β7 인테그린(Integrin) 억제제: Vedolizumab 주사제 (5) 스핑고신 1-인산염(Sphingosine 1-phosphate) 수용체 조절제: Ozanimod 경구제 나) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함.	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	라. (생 략) 2. ~ 4. (생 략)	라. (현행과 같음) 2. ~ 4. (현행과 같음)	
[142] Upadacitinib 경구제 (품명: 린버크서방정 15밀리그램, 30밀리그램)	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. ~ 3. (생 략) 4. 성인의 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염 가. ~ 나. (생 략) 다. 교체투여 1) 다음 약제에 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - 가) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제 나) 인터루킨(Interleukin, IL)-12/23	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1 ~ 3. (현행과 같음) 4. 성인의 중등도-중증 활동성 궤양성 대장염 가. ~ 나. (현행과 같음) 다. 교체투여 1) 다음 약제에 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - 가) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제 나) 인터루킨(Interleukin, IL)-12/23	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	억제제: Ustekinumab 주사제 <u><추 가></u> 다) α4β7 인테그린(Integrin) 억제제: Vedolizumab 주사제 라) 스펅고신 1-인산염(Sphingosine 1-phosphate) 수용체 조절제: Ozanimod 경구제 2) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함. 5. 성인의 중등도-중증 활성 크론병 가. ~ 나. (생 략) 다. 교체투여 1) 다음 약제에 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 등 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - 가) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab,	억제제: Ustekinumab 주사제 <u>다) 인터루킨(Interleukin, IL)-23 억제제: Guselkumab 주사제</u> <u>라) α4β7 인테그린(Integrin) 억제제: Vedolizumab 주사제</u> <u>마) 스펅고신 1-인산염(Sphingosine 1-phosphate) 수용체 조절제: Ozanimod 경구제</u> 2) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함. 5. 성인의 중등도-중증 활성 크론병 가. ~ 나. (현행과 같음) 다. 교체투여 1) 다음 약제에 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 등 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - 가) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab,	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	Infliximab 주사제 나) 인터루킨(Interleukin, IL)-12/23 억제제: Ustekinumab 주사제 <u><추 가></u> <u>다) α4β7 인테그린(Integrin) 억제제: Vedolizumab 주사제</u> 2) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함.	Infliximab 주사제 나) 인터루킨(Interleukin, IL)-12/23 억제제: Ustekinumab 주사제 <u>다) 인터루킨(Interleukin, IL)-23 억제제: Guselkumab 주사제</u> <u>라) α4β7 인테그린(Integrin) 억제제: Vedolizumab 주사제</u> 2) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함.	
[142] Ustekinumab 주사제 (품명: 스텔라라 프리필드주 45mg 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (생 략) 다. 크론병 1), 2) (생 략) 3) <u>종양괴사인자알파저해제 (TNF-α inhibitor: Adalimumab, Infliximab 주사제) 또는 Vedolizumab 주사제,</u>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (현행과 같음) 다. 크론병 1), 2) (현행과 같음) 3) <u>교체투여</u> <u>가) 다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	Upadacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. 라. 궤양성 대장염 1), 2) (생 략) 3) 중앙괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor):	경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - (1) 중앙괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: <u>Adalimumab, Infliximab 주사제</u> (2) 인터루킨(Interleukin, IL)-23 억제제: <u>Guselkumab 주사제</u> (3) $\alpha 4\beta 7$ 인테그린(Integrin) 억제제: <u>Vedolizumab 주사제</u> (4) 야누스 인산화효소(Janus kinase, JAK) 억제제: <u>Upadacitinib 경구제</u> 나) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함. 라. 궤양성 대장염 1), 2) (현행과 같음) 3) <u>교체투여</u>	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제) 또는 Vedolizumab 주사제, Tofacitinib, Filgotinib, Ozanimod, Upadacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.	가) 다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - (1) 중앙괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: <u>Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제</u> (2) 인터루킨(Interleukin, IL)-23 억제제: <u>Guselkumab 주사제</u> (3) $\alpha 4\beta 7$ 인테그린(Integrin) 억제제: <u>Vedolizumab 주사제</u> (4) 야누스 인산화효소(Janus kinase, JAK) 억제제: <u>Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib 경구제</u> (5) 스펅고신 1-인산염(Sphingosine 1-phosphate) 수용체 조절제:	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	2. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF- α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.	<u>Ozanimod 경구제</u> <u>나) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함</u> 2. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.	
[439] Vedolizumab 주사제 (품명: 킨텔레스주 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (생 략) 2. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제, 또는 Ustekinumab 주사제, Tofacitinib, Filgotinib, Ozanimod, Upadacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 나. (현행과 같음) 2. <u>교체투여</u> <u>가. 다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부)</u>	

- 25 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유
	현 행	개 정(안)	
	있는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함.	- 다 음 - 1) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: <u>Adalimumab, Golimumab, Infliximab 주사제</u> 2) 인터루킨(Interleukin, IL)-12/23 억제제: <u>Ustekinumab 주사제</u> 3) 인터루킨(Interleukin, IL)-23 억제제: <u>Guselkumab 주사제</u> 4) 야누스 인산화효소(Janus kinase, JAK) 억제제: <u>Tofacitinib, Upadacitinib, Filgotinib 경구제</u> 5) 스펅고신 1-인산염(Sphingosine 1-phosphate) 수용체 조절제: <u>Ozanimod 경구제</u> <u>나. 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함</u>	
	3. ~ 5. (생 략)	3. ~ 5. (현행과 같음)	

- 26 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Tofacitinib 경구제 (품명: 젤잔즈정 5밀리그램, 젤잔즈시럽 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 다. (생 략) 라. 중증의 강직성척추염 1) 투여대상 <u>1종 이상의 중양과사인자알파저해제(TNF-α inhibitor) 또는 IL-17A inhibitor에 반응이 불충분하거나 부작용 등으로 치료를 중단한 「중증의 활동성 강직성 척추염」 환자</u>	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 중증의 강직성척추염 1) 투여대상 <u>두 가지 종류 이상의 비스테로이드항염제(NSAIDs) 혹은 DMARDs로 3개월 이상 치료를 하였으나 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한, 중증의 활동성 강직성 척추염 환자</u> <u>- 다만, 65세 이상 환자, 심혈관계 고위험군 환자, 악성 종양 위험이 있는 환자에서는 기존 치료제(TNF 억제제 등 생물학적 제제)에 적절히 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 이 약을 사용하여야 함.</u>	○ 국내외 허가사항 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 (전문가) 의견 등을 참조하여, 중증의 강직성 척추염에서 TNF 억제제 및 IL-17 억제제와 동일한 투여대상 기준을 적용하는 것으로 급여기준 확대

- 27 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Upadacitinib 경구제(품명: 린버크서방정 15밀리그램, 30밀리그램)	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. ~ 2. (생 략) 3. 성인의 중증의 활동성 강직성 척추염 가. 투여대상 <u>다음은 만족하면서 1종 이상의 TNF 억제제 또는 인터루킨-17A 억제제에 반응이 불충분하거나 부작용 등으로 치료를 중단한 경우</u>	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함 - 아 래 - 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 성인의 중증의 활동성 강직성 척추염 가. 투여대상 <u>두 가지 종류 이상의 비스테로이드항염제(NSAIDs) 혹은 DMARDs로 3개월 이상 치료를 하였으나 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한, 중증의 활동성 강직성 척추염 환자</u> <u>- 단, 65세 이상, 심혈관계 고위험군, 악성 종양 위험이 있는 경우 기존 치료제(생물학적 제제)에 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 동 약제를 사용하여야 함.</u>	
※ 관련근거 - 식품의약품안전처 허가사항			

- 28 -

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
- Harrison’s Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 374: Spondyloarthritis - AXIAL SPONDYLOARTHRITIS - Goldman-Cecil Medicine, 27e, 2024 > Chapter. Spondyloarthritis - Conn’s Current Therapy 2025 > Book Chapter. Oncologic Emergencies - Firestein & Kelley’s Textbook of Rheumatology 12e, 2025 > Chapter 76. Axial Spondyloarthritis - Ramiro, S. et al. ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update. Ann. Rheum. Dis. 82, 19-34(2022) - Korean treatment recommendations for patients with axial spondyloarthritis(2023) - Pan American League of Associations for Rheumatology recommendations for the management of axial spondyloarthritis(2023) - Canadian Rheumatology Association/Spondyloarthritis Research Consortium of Canada Recommendations for the Management of Axial Spondyloarthritis(2025) - Saudi Clinical Practice Guidelines for Management of Axial Spondyloarthritis Disease(2025) - Efficacy and safety of upadacitinib in patients with active ankylosing spondylitis (SELECT-AXIS 1): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2/3 trial(van der Heijde D, Song I-H, Pangan AL, et al., Lancet 2019;394:2108-17) - Upadacitinib in active ankylosing spondylitis: results of the 2-year, double-blind, placebo-controlled SELECT-AXIS 1 study and open label extension(van der Heijde D, et al., RMD Open 2022;8:e002280. doi:10.1136/rmdopen-2022-002280) - Efficacy and safety of upadacitinib in patients with active ankylosing spondylitis refractory to biologic therapy: 2-year clinical and radiographic results from the open-label extension of the SELECT-AXIS 2 study(Baraliakos et al. Arthritis Research & Therapy (2024) 26:197 https://doi.org/10.1186/s13075-024-03412-8) - Tofacitinib for the treatment of ankylosing spondylitis: a phase III, randomised, double-blind, placebo-controlled study(Deodhar A, et al. Ann Rheum Dis 2021;80:1004-1013) - Efficacy and safety of IL inhibitors, TNF-α inhibitors, and JAK inhibitors in patients with ankylosing spondylitis: a systematic review and Bayesian network meta-analysis(Cong Tian, Ann transe Med 2023 Feb 28;11(4)178. doi: 10.21037/atm-23-195) - NICE(2022) - SMC(2022) - PBAC(2023) - CADTH(2023)			

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Tofacitinib 경구제 (품명: 젤잔즈정 5밀리그램, 젤잔즈시럽 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정 하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 라. (생 략) <u><신 설></u>	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정 하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. ~ 라. (현행과 같음) <u>마. 건선성 관절염</u> <u>1) 투여대상(모두 만족)</u> <u>가) 각 3개 이상의 압통 관절과 부종 관절</u> <u>- 1개월 간격으로 2회 이상의 연속 측정 결과여야 함.</u> <u>나) 선행치료</u> <u>두 종류 이상의 DMARDs로 총 6개월 이상(각 3개월 이상) 치료하였으나, 치료효과가 미흡하거나 부작용 등으로 치료를 중단한 경우</u> <u>- 다만, 65세 이상, 심혈관계 고위험군, 악성 종양 위험이 있는 경우 기존 치</u>	○ 국내외 허가사항 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 (전문가) 의견 등을 참조하여, 건선성 관절염에 급여기준을 확대

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>료제(TNF 억제제 등 생물학적 제제)에 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 동 약제를 사용하여야 함.</u> 2) 평가방법 가) 3개월 투여 후 평가(최초 평가): 활성관절수 30% 이상 감소 시 인정 나) 이후 6개월마다 평가: 최초 평가결과 유지 시 인정 3) 교체투여 가) 다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약 순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - (1) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab, Infliximab, Etanercept, Golimumab 주사제 (2) 인터루킨(Interleukin, IL)-17 억제제: Ixekizumab, Secukinumab 주사제	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		(3) IL-12/23 억제제: Ustekinumab 주사제 (4) IL-23 억제제: Guselkumab, Risankizumab 주사제 (5) 포스포디에스테라제-4 (Phosphodiesterase-4 PDE4) 억제제: Apremilast 경구제 (6) JAK억제제: Upadacitinib 경구제 나) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함	
[142] Upadacitinib 경구제(품명: 린버크서방정 15밀리그램, 30밀리그램)	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) 6. 성인의 활동성 및 진행성 건선성 관절염 가. 투여대상(모두 만족) 1) 각 3개 이상의 압통 관절과 부종 관절 - 1개월 간격으로 2회 이상의 연속 측정 결과여야 함. 2) 선행치료	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (현행과 같음) 6. 성인의 활동성 및 진행성 건선성 관절염 가. 투여대상(모두 만족) 1) 각 3개 이상의 압통 관절과 부종 관절 - 1개월 간격으로 2회 이상의 연속 측정 결과여야 함. 2) 선행치료	○ Tofacitinib 경구제가 건선성 관절염에 급여기준이 확대됨에 따라, 타 약제의 교체투여 대상에 명시

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	두 종류 이상의 DMARDs로 총 6개월 이상(각 3개월 이상) 치료하였으나, 치료효과가 미흡하거나 부작용 등으로 치료를 중단한 경우 - 다만, 65세 이상, 심혈관계 고위험군, 약성 종양 위험이 있는 경우 기존 치료제(TNF 억제제 등 생물학적 제제)에 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 동 약제를 사용하여야 함. 나. 평가방법 1) 3개월 투여 후 평가(최초 평가): 활성 관절수 30% 이상 감소 시 인정 2) 이후 6개월마다 평가: 최초 평가결과 유지 시 인정 다. 교체투여 1) 다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - 가) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab,	두 종류 이상의 DMARDs로 총 6개월 이상(각 3개월 이상) 치료하였으나, 치료효과가 미흡하거나 부작용 등으로 치료를 중단한 경우 - 다만, 65세 이상, 심혈관계 고위험군, 약성 종양 위험이 있는 경우 기존 치료제(TNF 억제제 등 생물학적 제제)에 반응하지 않거나 내약성이 없는 경우에 한하여 동 약제를 사용하여야 함. 나. 평가방법 1) 3개월 투여 후 평가(최초 평가): 활성 관절수 30% 이상 감소 시 인정 2) 이후 6개월마다 평가: 최초 평가결과 유지 시 인정 다. 교체투여 1) 다음 약제 투여에도 효과가 없거나 부작용으로 지속 투여가 불가능한 경우, 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우 동 약제로 교체투여를 인정함(투여소견서 첨부) - 다 음 - 가) 종양괴사인자(Tumor necrosis factor, TNF) 억제제: Adalimumab,	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	Infliximab, Etanercept, Golimumab 주사제 나) 인터루킨(Interleukin, IL)-17 억제제: Ixekizumab, Secukinumab 주사제 다) IL-12/23 억제제: Ustekinumab 주사제 라) IL-23 억제제: Guselkumab, Risankizumab 주사제 마) 포스포디에스테라제-4 (Phosphodiesterase -4, PDE4) 억제제: Apremilast 경구제 <추 가> 2) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함. (이하 생략)	Infliximab, Etanercept, Golimumab 주사제 나) 인터루킨(Interleukin, IL)-17 억제제: Ixekizumab, Secukinumab 주사제 다) IL-12/23 억제제: Ustekinumab 주사제 라) IL-23 억제제: Guselkumab, Risankizumab 주사제 마) 포스포디에스테라제-4 (Phosphodiesterase -4, PDE4) 억제제: Apremilast 경구제 바) JAK억제제: Tofacitinib 경구제 2) 교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지를 권고함. (이하 생략)	
[142] Apremilast 경구제(품명 : 오테리아정 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 활동성 및 진행성 건선성 관절염	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 활동성 및 진행성 건선성 관절염	○ Tofacitinib 경구제가 건선성 관절염에 급여기준이 확대됨에 따라, 타 약제의 교체투여 대상에 명시

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	1) 투여대상 두 가지 종류 이상의 DMARDs로 총 6개월 이상(각 3개월 이상) 치료하였음에도 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자로서 다음 조건에 부합하는 경우 - 다 음 - ○ 3개 이상의 압통 관절과 3개 이상의 부종 관절이 존재하여야 하며, 1개월 간격으로 2회 연속 측정된 결과이어야 함. 2) 평가방법 가) 동 약제를 16주간 사용 후 활성 관절수가 최초 투여시점 보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가를 하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 추가투여를 인정함.	1) 투여대상 두 가지 종류 이상의 DMARDs로 총 6개월 이상(각 3개월 이상) 치료하였음에도 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자로서 다음 조건에 부합하는 경우 - 다 음 - ○ 3개 이상의 압통 관절과 3개 이상의 부종 관절이 존재하여야 하며, 1개월 간격으로 2회 연속 측정된 결과이어야 함. 2) 평가방법 가) 동 약제를 16주간 사용 후 활성 관절수가 최초 투여시점 보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가를 하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 추가투여를 인정함.	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	(중 략) 2 종 양 괴 사 인 자 알 파 저 해 제 (TNF-α inhibitor: Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제), Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab, Risankizumab, Bimekizumab 주사제, Deucravacitinib, Upadacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. (이하 생략)	(중 략) 2. 종 양 괴 사 인 자 알 파 저 해 제 (TNF-α inhibitor: Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제), Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab, Risankizumab, Bimekizumab 주사제, Deucravacitinib, Upadacitinib, Tofacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. (이하 생략)	
[142] Ustekinumab 주사제(품명:	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	○ Tofacitinib 경구제가 건선성 관절염에 급여기준이 확대됨에

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
스텔라라프리필드주 45mg 등)	- 아 래 - (중 략) 나. 활동성 및 진행성 건선성 관절염 1) 투여대상 1종 이상의 중양피사인자알파저해제 (TNF-α inhibitor) 또는 IL-17 inhibitor에 반응이 불충분하거나 부작용, 금기 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자 2) 평가방법 가) 동 약제를 6개월 사용 후 활성 관절 수가 최초 투여시점보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여	- 아 래 - (중 략) 나. 활동성 및 진행성 건선성 관절염 1) 투여대상 1종 이상의 중양피사인자알파저해제 (TNF-α inhibitor) 또는 IL-17 inhibitor, <u>PDE4 억제제, JAK 억제제</u>에 반응이 불충분하거나 부작용, 금기 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자 2) 평가방법 가) 동 약제를 6개월 사용 후 활성 관절 수가 최초 투여시점보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여	따라, 타 약제의 교체투여 대상에 명시

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	한 적이 없는 TNF-α inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Guselkumab, Risankizumab 주사제, Apremilast, Upadacitinib 경구제로 교체 투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 조건서를 첨부하여야 함. (이하 생략)	한 적이 없는 TNF-α inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Guselkumab, Risankizumab 주사제, Apremilast, Upadacitinib, <u>Tofacitinib</u> 경구제로 교체투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 조건서를 첨부하여야 함. (이하 생략)	
[142] Guselkumab 주사제(품명: 트렘피어프리필드시린지주 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) 다. 활동성 및 진행성 건선성 관절염 1) 투여대상 1종 이상의 중양피사인자알파저해제	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) 다. 활동성 및 진행성 건선성 관절염 1) 투여대상 1종 이상의 중양피사인자알파저해제	○ Tofacitinib 경구제가 건선성 관절염에 급여기준이 확대됨에 따라, 타 약제의 교체투여 대상에 명시

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	(TNF-α inhibitor) 또는 IL-17 inhibitor에 반응이 불충분하거나 부작용, 금기 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자 2) 평가방법 가) 동 약제를 6개월 사용 후 활성 관절 수가 최초 투여시점보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-α inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Risankizumab 주사제, Apremilast, Upadacitinib 경구제로 교체 투여(Switch)하는 경우 급여를 인정	(TNF-α inhibitor) 또는 IL-17 inhibitor, <u>PDE4 억제제</u>, <u>JAK 억제제</u>에 반응이 불충분하거나 부작용, 금기 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자 2) 평가방법 가) 동 약제를 6개월 사용 후 활성 관절 수가 최초 투여시점보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-α inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Risankizumab 주사제, Apremilast, Upadacitinib, <u>Tofacitinib</u> 경구제로 교체투여(Switch)하는 경우	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. (이하 생략)	급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. (이하 생략)	
[142] Risankizumab 주사제(품명: 스카이리치프리필드 시린지주 등)	1. 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) 나. 활동성 및 진행성 건선성 관절염 1) 투여대상 1종 이상의 중양괴사인자알파저해제 (TNF-α inhibitor) 또는 IL-17 inhibitor에 반응이 불충분하거나 부작용, 금기 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자 2) 평가방법 가) 동 약제를 6개월 사용 후 활성 관절	1. 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) 나. 활동성 및 진행성 건선성 관절염 1) 투여대상 1종 이상의 중양괴사인자알파저해제 (TNF-α inhibitor) 또는 IL-17 inhibitor, <u>PDE4 억제제</u>, <u>JAK 억제제</u>에 반응이 불충분하거나 부작용, 금기 등으로 치료를 중단한 활동성 및 진행성 건선성 관절염 환자 2) 평가방법 가) 동 약제를 6개월 사용 후 활성 관절	○ Tofacitinib 경구제가 건선성 관절염에 급여기준이 확대됨에 따라, 타 약제의 교체투여 대상에 명시

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	수가 최초 투여시점보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-α inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab 주사제, Apremilast, Upadacitinib 경구제로 교체 투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. (이하 생략)	수가 최초 투여시점보다 30% 이상 감소된 경우 추가 6개월간의 사용을 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 6개월째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 3) 동 약제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없어 이전에 투여한 적이 없는 TNF-α inhibitor(Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Golimumab 주사제) 또는 Secukinumab, Ixekizumab, Ustekinumab, Guselkumab 주사제, Apremilast, Upadacitinib, Tofacitinib 경구제로 교체투여(Switch)하는 경우 급여를 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여 소견서를 첨부하여야 함. (이하 생략)	

[612] 주로 그람음성균에 작용하는 것

- 41 -

현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[612] Aztreonam 주사제 (품명: 메작탐주사 등)	1. <u>허가사항 범위</u> 내에서 요양급여 함을 원칙으로 하며, 1차 약제투여로 증상이 호전되지 않는 환자에게 2차 약제로 투여하여야 함. 2. 동 약제의 특·장점 및 효능·효과 등을 고려하여 타 항생제에 내성이 있는 그람음성균 감염환자, 면역기능 저하환자, 중증감염환자 등의 경우에 치료 상 필요하여 선택적으로 투여한 경우에는 요양급여를 인정함	[612] Aztreonam 주사제 (품명: <u>호스피라아르트레오남 주사제1그램</u>)	1. 식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 요양급여 함을 원칙으로 하며, 1차 약제투여로 증상이 호전되지 않는 환자에게 2차 약제로 투여하여야 함. 2. 동 약제의 특·장점 및 효능·효과 등을 고려하여 타 항생제에 내성이 있는 그람음성균 감염환자, 면역기능 저하환자, 중증감염환자 등의 경우에 치료 상 필요하여 선택적으로 투여한 경우에는 요양급여를 인정함 ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위 - 신우신염·방광염 등 요로감염증, - 폐렴·기관지염 등 하기도감염증, - 폐혈증, 피부·연조직 감염증, - 복막염 등 복강 내 감염, - 자궁내막염·골반연조직염 등 부인과 감염 등 아르트레오남에 감수성 있는 감염증	○ 기존 Aztreonam 주사제가 급여 목록표에서 삭제되었고 동일 성분 미허가 긴급도입의약품인 ‘호스피라아르트레오남 주사제1그램’이 신규 등재예정인므로 이를 반영하여 식품의약품안전처장이 인정하는 범위 내로 급여기준을 변경함.
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경>				

- 42 -

[629] 기타의 화학요법제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[629] Glecaprevir+ Pibrentasvir 경구제 (품명: 마비렛정)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (생 략) <u><신 설></u>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (현행과 같음) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 투여대상 만 3세 이상 만 12세 미만인 소아의 유전자 1,2,3,4,5,6형 만성 C형 간염 나. 투여 방법·기간: 다음 표에 따라 1일 1회, 8주 - 다 음 -	○ 국내외 허가사항 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 (전문가) 의견 등을 참조하여, 만성 C형 간염에 급여기준을 확대

		<table><tr><th>체 중</th><th>용 량</th></tr><tr><td>12kg 이상 ~ 20kg 미만</td><td>150mg/60mg</td></tr><tr><td>20kg 이상 ~ 30kg 미만</td><td>200mg/80mg</td></tr><tr><td>30kg 이상 ~ 45kg 미만</td><td>250mg/100mg</td></tr><tr><td>45kg 이상</td><td>300mg/120mg</td></tr></table>	체 중	용 량	12kg 이상 ~ 20kg 미만	150mg/60mg	20kg 이상 ~ 30kg 미만	200mg/80mg	30kg 이상 ~ 45kg 미만	250mg/100mg	45kg 이상	300mg/120mg	
체 중	용 량												
12kg 이상 ~ 20kg 미만	150mg/60mg												
20kg 이상 ~ 30kg 미만	200mg/80mg												
30kg 이상 ~ 45kg 미만	250mg/100mg												
45kg 이상	300mg/120mg												
	나. 혈중 ALT(Alanine Transaminase) 수치 증가 등 환자상태에 따라 Hepatotonics(Carduus marianus ext., Ursodeoxycholic acid, DDB 함유 제제 등)와의 병용투여는 인정 가능하나, 동 약제와 Hepatotonics 중 1종의 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	3. (현행과 같음)											

※ 관련근거

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 22nd edition, 2025.
- Nelson Textbook of Pediatrics, 20th edition, 2025.
- 만성 C형 간염 진료 가이드라인, 2025, 대한간학회.
- EASL(European Association for the Study of the Liver) recommendations on treatment of hepatitis C, 2020.
- Hepatitis C Guidance 2023 Update: American Association for the Study of Liver Diseases(AASLD) Infectious Diseases Society of America(IDSA) Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection), 2023.
- Giuseppe Indolfi, et al. The efficacy and safety of direct-acting antivirals in children and adolescents with chronic hepatitis C virus infection, 2020.
- Maureen M. Jonas ,et al. Pharmacokinetics, Safety, and Efficacy of Glecaprevir / Pibrentasvir in Children With Chronic HCV: Part 2 of the DORA Study, 2021.
- Aisha M Alamri, et al. isha M Alamri, Wijdan A Almeahman, Management of Pediatric Chronic Hepatitis C with Crushed or

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[629] Sofosbuvir + Velpatasvir 경구제 (품명: 엡클루사정)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. <u>투여대상 <문구 정비></u> 성인, 만 12세 이상이고 체중 30kg이상인 소아의 유전자 1,2,3,4,5,6형 만성 C형 간염 나. 투여방법 이전 치료 경험이 없거나, 인터페론, 페그인터페론±리바비린 치료에 실패한 경우 다음과 같이 투여 - 다 음 - 1) 간경변이 없거나 대상성 간경변 있는 경우: 단독 12주 2) 비대상성 간경변 있는 경우: 리바비린 병용 12주	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 성인, 만 12세 이상이고 체중 30kg이상인 소아의 유전자 1,2,3,4,5,6형 만성 C형 간염 ○ 투여방법 이전 치료 경험이 없거나, 인터페론, 페그인터페론±리바비린 치료에 실패한 경우 다음과 같이 투여 - 다 음 - 1) 간경변이 없거나 대상성 간경변 있는 경우: 단독 12주 2) 비대상성 간경변 있는 경우: 리바비린 병용 12주	○ 국내외 허가사항 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 (전문가) 의견 등을 참조하여, 만성 C형 간염에 급여기준을 확대

	※ 이전 치료에 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. <u>투여대상 <문구 정비></u> 성인, 만 12세 이상이고 체중 30kg이상인 소아의 유전자 1,2,3,4,5,6형 만성 C형 간염 나. 투여방법 다음은 모두 만족하고, 비대상성 간경변이 있는 경우 동 약제 24주 단독 인정 - 다 음 - 가) 이전 치료 경험이 없거나, 인터페론, 페그인터페론±리바비린 치료에 실패한 경우 나) 부작용 등 리바비린을 투여할 수 없는 경우 ※ 이전 치료에 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상	※ 이전 치료에 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 성인, 만 12세 이상이고 체중 30kg이상인 소아의 유전자 1,2,3,4,5,6형 만성 C형 간염 ○ 투여방법 다음은 모두 만족하고, 비대상성 간경변이 있는 경우 동 약제 24주 단독 인정 - 다 음 - 1) 이전 치료 경험이 없거나, 인터페론, 페그인터페론±리바비린 치료에 실패한 경우 2) 부작용 등 리바비린을 투여할 수 없는 경우 ※ 이전 치료에 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상	
--	---	--	--

	<u><신 설></u> 3. 혈중 ALT(Alanine Transaminase) 수치 증가 등 환자상태에 따라 Hepatotonics(Carduus marianus ext., Ursodeoxycholic acid, DDB 함유 제제 등) 와의 병용투여는 인정 가능하나, 동 약제와 Hepatotonics 중 1종의 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	나. 만 6세 이상 12세 미만이고 체중 30kg이상인 소아의 유전자 1,2,3,4,5,6형 만성 C형 간염 ○ 투여방법 1일 1회 1정, 단독 12주 3. (현행과 같음)	
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22nd edition, 2025. · Nelson Textbook of Pediatrics, 20th edition, 2025. · 만성 C형 간염 진료 가이드라인, 2025, 대한간학회. · EASL(European Association for the Study of the Liver) recommendations on treatment of hepatitis C, 2020. · Hepatitis C Guidance 2023 Update: American Association for the Study of Liver Diseases(AASLD) Infectious Diseases Society of America(IDSA) Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection), 2023. · Giuseppe Indolfi, et al. The efficacy and safety of direct-acting antivirals in children and adolescents with chronic hepatitis C virus infection, 2020. · Dania Brigham et al. Profile of Sofosbuvir and Velpatasvir Combination in the Treatment of Chronic Hepatitis C in Children and Adolescents: Current Evidence. Therapeutics and Clinical Risk Management, 2024.			

· Maureen M Jonas,et al. Sofosbuvir-velpatasvir in children 3-17 years old with hepatitis C virus infection, 2024. · Maria Pokorska - Śpiewak,et al.Efficacy and safety of treatment with sofosbuvir/velpatasvir in patients aged 6-18 years with chronic hepatitis C-Results of the PANDAA-PED study , 2023.
--